Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção B da 7ª Vara Cível da Capital

, S/N, FORUM RODOLFO AURELIANO, RECIFE - PE - CEP: 50080-800 - F:(81) 31810373

Processo nº 0153939-60.2023.8.17.2001

AUTOR(A): RAQUEL MIRELLA SILVA DE ALBUQUERQUE

RÉU: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

SENTENÇA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO OBRIGAÇÃO FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTORA PORTADORA DE DOENÇA DE CASTLEMAN. ENFERMIDADE RARA. PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA USO DO MEDICAMENTO SILTUXIMAB (SYLVANT) 640 MG EV, APLICADO A CADA 21 DIAS, DURANTE UM TOTAL DE 12 (DOZE) CICLOS. NEGATIVA DE FORNECIMENTO. ALEGAÇÃO DE USO EXPERIMENTAL (OFF-LABEL). MEDICAMENTO PRESCRITO CONSIDERADO IMPRESCINDÍVEL AO COMBATE DA ENFERMIDADE. ABUSIVIDADE DA RECUSA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROCEDENTE.

- Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde. Súmula 608 do STJ.

- Autora diagnosticada com doença de Castleman, tipo de câncer raro que atinge os gânglios e tecidos linfáticos sem causa conhecida, que afetou predominantemente a região mediastinal.

- É abusiva a negativa da cobertura pelo plano de saúde de tratamento/medicamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente, ainda que se trate da hipótese de tratamento experimental ou off label. Precedentes

- O Superior Tribunal de Justiça já apascentou que "*o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura*" (AgRg no REsp 1500631/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 15/04/2015

- É abusiva a negativa de fornecimento de medicamentos pela empresa operadora tão somente pelo fato de serem ministrados em ambiente ambulatorial ou domiciliar.

- A negativa de cobertura fundada em cláusula abusiva de contrato de assistência à saúde pode dar ensejo à indenização por dano moral. Súmula 35 do TJPE.

- Procedência dos pedidos.

Vistos etc.

Cogita-se, na espécie, de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais manejada por **RAQUEL MIRELLA SILVA DE ALBUQUERQUE** em face de **HAPVIDA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA,** ambos devidamente qualificadas e representados nos autos**.**

Alega a parte autora que, na condição de beneficiária do plano de saúde Réu com matrícula número 3010J.071554/00-9/02-0, e estando com suas obrigações em dia, está em acompanhamento nio ambulatório de hematologia, devido a doença de Castleman que a acomete, tendo sido confirmada a enfermidade por exames anatomopatológico + imunohistoquímica.

Segundo afirma, já realizou tratamento de pulsoterapia com corticoide e rituximabe, apresentando resposta totalmente ineficaz. Aduz que também já se submeteu a radioteria, num total de 23 sessões, no período de 19.09.2022 a 26.10.2022, possuindo resposta eficiente para a redução das dimençoes da massa linfonodal mediastinal, de limites imprecisos.

Ocorre que, apesar de ainda permanecer com massa mediastinal de tamanho significativo e ter dido refratparia a inpumeas medidas terapêuticas prévias, fora-lhe prescrito, por seu médico assiste Dr. Ícaro Félix CRM 21.946, tratamento medicamentoso com a substância Siltuximab (Sylvant), salientando ainda que a autora possui sorologia negativa para HIV e Herpes Vírus, HHV8.

Nesse estado de coisas, apesar de ter sido realizado o pedido administrativo de fornecimento do medicamento ao plano de saúde, a operadora Ré entendeu por negar a cobertura, sob a alegativa de não atendimento aos critérios de Diretriz de Utilização (DUT 64) estabelecidos pela ANS.

Em face desse estado de coisas, veio a Juízo pleitear tutela de urgência de caráter antecipatório para o fim de impor a obrigação de cobertura do medicamente referenciado, enquanto dele necessitar, à vista da recomendação do médico assistente, além de indenização por danos morais, os quais fixou no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Juntou instrumento procuratório, documentação instrutória e requereu a gratuidade judiciária

Decisão interlocutória proferida no Id. 154197050 (https://pje.tjpe.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=4677238&ca=857b12b3a81ae48c4621cedc1ebfed91dfc8e86d204c44ba5a8984f9172cfc35f55e54d297 deferindo a gratuidade e tutela de urgência requerida e determinando a citação do Réu.

Petição da Ré HAPVIDA atravessada no Id. 158800355 (https://pje.tjpe.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=4677238&ca=857b12b3a81ae48c4621cedc1ebfed91dfc8e86d204c44ba5a8984f9172cfc35f55e54d297 informando a interposição de recurso instrumentado.

Em sequencia, apresentou sua defesa à petição inicial no Id. 159405241 (https://pje.tjpe.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=4677238&ca=857b12b3a81ae48c4621cedc1ebfed91dfc8e86d204c44ba5a8984f9172cfc35f55e54d297 basenado seus argumentos no uso *off-label* do medicamento prescrito, na ausência de exames recentes de triagem para o vírus HHV-8 da autora, que seriam necessários para avaliar a pertinência do fornecimento da medicação pela auditoria. Ao enfim, defendeu ser lícita a negativa por expressa previsão contratual, pelo que defendeu inexistir dever de indenizar.

Réplica apresentada no Id. 162312509 (https://pje.tjpe.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=4677238&ca=857b12b3a81ae48c4621cedc1ebfed91dfc8e86d204c44ba5a8984f9172cfc35f55e54d297 Na ocasião, a demandante enfatizou o descumprimento da liminar e solicitou o bloqueio de valores suficientes para cobrir o tratamento medicamentoso. Para fundamentar o pedido, apresentou dois orçamentos, registrados sob os IDs nº 156218709.

Decisão determinando o bloqueio dos valores necessários ao tratamento da autora (Id 164925216).

Pedido de retratação apresentado pela operadora de saúde em Id 169310491

Despacho proferido no id. 169708654 (https://pje.tjpe.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=4677238&ca=857b12b3a81ae48c4621cedc1ebfed91dfc8e86d204c44ba5a8984f9172cfc35f55e54d297, mantendo em todos os seus termos a decisão e determinando que as partes manifestassem seus interesses na dilação probatória. Em resposta, a parte autora requereu o julgamento antecipado da lide (Id. 170836471 (https://pje.tjpe.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=4677238&ca=857b12b3a81ae48c4621cedc1ebfed91dfc8e86d204c44ba5a8984f9172cfc35f55e54d297). A operadora demandada pleiteou a produção de prova pericial (Id n 171267029) cuja negativa restou exarada na decisão de Id 171360711.

Houve alegações finais reiterativas

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. **Decido.**

Cuida-se de pretensão que encerra obrigação de fazer cumulada com reparação de danos, de conhecida possibilidade jurídica, aviada entre partes com legitimidade *'ad causam'* e interesse de agir, porquanto aforada por beneficiária de seguro de saúde em face da respectiva seguradora.

O cerne do debate reside na obrigatoriedade de cobertura de medicamento Siltuximab (Sylvant) 640 MG EV, aplicado a cada 21dias, por um total de 12 (doze) ciclos, em face de ter sido a autora diagnosticada com doença de Castleman, tipo de câncer raro que atinge os gânglios e tecidos linfáticos sem causa conhecida, que afetou a autora predominantemente em região mediastinal.

inicialmente, assento que ao caso concreto são aplicadas as regras de proteção ao consumidor, em conformidade com a **Súmula 608, do Superior Tribunal de Justiça**.

Na hipótese *sub judice,* comprovou a parte Autora que firmou com a Ré contrato de plano de saúde (Id 1554137059) e quem tinha indicação médica para realizar o tratamento perseguido (Id 154137072), o que dá supedâneo à pretensão cominatória formulada na peça vestibular.

No relatório médico, o hematologista atestou acerca da patologia:

RELATÓRIO MÉDICO

Paciente **RAQUEL MIRELLA SILVA DE ALBUQUERQUE**, está
acompanhamento no ambulatório de hematologia, devido doença de Castl
confirmado por anatomopatológico + imunohistoquímica.
Tem doença predominantemente em região mediastinal com massa avaliad
equipe de cirurgia torácica e considerada irressecável, devido comprometimen
vasos sanguíneos importantes.
Já realizou tratamento de pulsoterapia com corticoide e Rituximabe, apresen
resposta totalmente ineficaz.
Foi submetida a radioterapia, num total de 23 sessões no período de 19/09/2
26/10/2022. Realizou tomografias de controle após este último tratamento, as
evidenciaram, em região de tórax, "redução das dimensões da massa linfo
mediastinal, de limites imprecisos no estudo atual, medindo cerca de 6,9 cm e
maior diâmetro no plano axial (medida anterior: 9,1 cm)."
Apesar disto, diante do fato de ainda permanecer com massa de tamanho signific
e ter sido refratária a inúmeras medidas terapêuticas prévias, indico que pacient
a necessidade de tratamento com siltuximab (Sylvant), o qual tem indicação f
de tratamento para paciente portadores de Doença de Castleman – vale ressalta
paciente tem sorologias negativas para HIV e Herpes Vírus, HHV8, sendo, por
candidata apta à mesma.

CID-10: R59.1

Consoante se infere da documentação acostada, afigura-se induvidoso que está a parte reclamante/consumidora a pleitear cobertura para medicamento que objetiva sua reabilitaçãO em face da doença que periclita sua própria vida, notadamente em função da falta de resposta aos tratamentos ortodoxos.

Periclitado o estado de saúde do paciente portador da grave moléstia, remansa o quadro clínico gravoso descrito na peça vestibular, razão pela qual se afigura imperativo o aprofundamento de seu tratamento com vista ao acautelamento dos perversos danos experimentados, como defesa dos direitos fundamentais de proteção da vida e da incolumidade física e psíquica (art. 196 e segs., da CF de 1988), sendo certo que, há muito, a jurisprudência vem entendendo por abusiva a extirpação arbitrária ou a protelação de tratamentos nos dispositivos contratuais deste jaez.

Em análise a peça de defesa, observa-se que a ré baseou seus argumentos no uso *off-label* do medicamento prescrito e na ausência de exames recentes de triagem para o vírus HHV-8 da autora, que seriam necessários para avaliar a pertinência do fornecimento da medicação pela auditoria.

Registre-se, por oportuno, que cabe ao profissional da saúde indicar o tratamento a ser experimentado pela paciente, e não ao plano de saúde. Vale dizer: o médico e não o plano de saúde é responsável pela orientação terapêutica e que entender de modo diverso põe em risco a vida do consumidor.

Neste mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou que "*o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura*" (AgRg no REsp 1500631/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 15/04/2015).

Ademais, importante enfatizar que a negativa para o vírus HHV-8 (Herpesvirus humano tipo 8) e HIV já foi esclarecido no laudo médico identificado pelo ID nº 154137072, informação, inclusive, já mencionada na liminar deferida.

Outrossim, conforme entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça o uso *off-label* do medicamento não altera o dever de fornecimento pela operadora pois "*quem decide se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações da bula/manual da ANVISA daquele específico remédio é o profissional médico. Autorizar que a operadora negue a cobertura de tratamento sob a justificativa de que a doença do paciente não está contida nas indicações da bula representa inegável ingerência na ciência médica, em odioso e inaceitável prejuízo do paciente enfermo" (REsp n. 1.769.557/CE, Relatora a Ministra Nancy Andrigui, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018*)"

Nesse sentido:

> CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO OFF LABEL. RECUSA INDEVIDA. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. **É abusiva a negativa da cobertura pelo plano de saúde de tratamento/medicamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente, ainda que se trate da hipótese de tratamento experimental ou off label.** 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteú do do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no REsp: 1989283 RN 2022/0050242-0, Data de Julgamento: 08/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022)

> AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CONCLUSÃO NO SENTIDO DE SER INDICAÇÃO DE TRATAMENTO OFF-LABEL. SÚMULA 7/STJ. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO OFF-LABEL. CABIMENTO DO FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O aresto estadual entendeu que a indicação dos remédios receitados configurou uso off-label. Aplicação da Súmula 7/STJ. 2. **O fato de os fármacos em questão - Avastin (Bevacizumabe) e Temodal (Temozolomida) - configurarem uso off-label, em nada afeta o dever de fornecimento, pois "quem decide se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações da bula/manual da ANVISA daquele específico remédio é o profissional médico. Autorizar que a operadora negue a cobertura de tratamento sob a justificativa de que a doença do paciente não está contida nas indicações da bula representa inegável ingerência na ciência médica, em odioso e inaceitável prejuízo do paciente enfermo" (REsp n. 1.769.557/CE, Relatora a Ministra Nancy Andrigui, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018).** 3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.712.163/SP e o REsp 1.726.563/SP (Rel. Ministro Moura Ribeiro, DJe 26/11/2018), representativos de controvérsia, firmou a tese repetitiva (Tema n. 990) segundo a qual "as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA". Porém, no caso concreto, não se trata de medicamento não registrado na autarquia, e sim de uso e indicação off-label, conforme consta no acórdão recorrido. Destarte, é aplicável ao caso o enunciado da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido.(STJ - AgInt no AREsp: 1677613 SP 2020/0057909-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2020)

Ainda, faz-se importante ressaltar que o medicamento em questão tem registro na ANVISA sob o nº 171260007, e o relatório médico anexado destaca que a autora já utilizou outros medicamentos que não apresentaram eficácia no tratamento, resultando em recidivas frequentes.

Desta forma, no caso posto a lume, anote-se que o tratamento é tido como fundamental para salvaguardar a vida do paciente e deve ser realizado mediante rigoroso acompanhamento médico, na forma e dentro do cronograma requisitado.

Em corroboração exata a este pensar, vide a jurisprudência recente desta Corte Estadual:

> Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Itabira de Brito Filho Avenida Martins de Barros, 593, 3º andar, Santo Antônio, RECIFE - PE - CEP: 50010-230 - F:() ÓRGÃO JULGADOR: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL COMARCA: RECIFE – 8ª VARA CÍVEL/SEÇÃO A TIPO: APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO Nº: PJE 0026312-58.2016.8.17.2001 APELANTE: SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A APELADA: ERIVANDA DE SOUZA CONDE RELATOR: DES. ITABIRA DE BRITO FILHO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE DOENÇA DE CASTLEMAN. ENFERMIDADE RARA. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO. ROL DA ANS. EXCLUSÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPROVIMENTO DO APELO. À UNANIMIDADE - Negativa de cobertura securitária pela Apelante, que defende não poder ser obrigada a suportar despesas advindas do uso da medicação SYLVANT (SILTUXIMAB) 400mg 2 FA SILTUXIMAB, necessário no tratamento de doença de Castleman, HIV e HHV8 negativos, na tentativa de preservar a saúde e vida da segurada, sob o argumento de que não constaria no rol da ANS, bem como que seria tratamento excluído da cobertura contratual, previsão esta constaria de forma clara no instrumento pactuado, possibilidade que seria inerente ao instituto do seguro e admitida na legislação pertinente - Todo o tratamento solicitado se revelou como medida indispensável para tratar doença de Castleman HIV e HHV8 negativos, doença rara que acometeu a segurada, que apresenta um quadro clínico com várias lesões cervicais tumoriais sem resposta aos tratamentos já realizados, conforme consignado pela médica que assistiu a paciente - O rol de procedimentos de cobertura obrigatória elaborado pela Agência Nacional de Saúde reveste-se, tão somente, de caráter de cobertura mínima a ser fornecida pelos planos de saúde aos seus segurados - Não cabe a seguradora determinar qual o tratamento médico deve ser realizado no combate à doença que acomete a segurada - Não podem ser excluídas do seguro as despesas advindas de prescrição médica e a negativa de cobertura resulta em rompimento do equilíbrio contratual, afrontando os princípios da confiança e boa-fé objetiva que devem reger a relação entre as partes - A postura da seguradora, em querer se eximir da responsabilidade de custear a medicação solicitada acaba por impor à relação jurídica um desequilíbrio injustificado, pelos excessos cometidos, donde se impõe a incidência do CDC - Dano moral configurado, decorrentes do descumprimento de obrigação e da quebra de confiança do cliente na empresa contratada - Agravamento da situação de aflição da segurada quando, ao buscar a autorização para a realização do tratamento, depara-se com resposta negativa da seguradora quanto aos medicamentos necessários ao seu êxito - Verba indenizatória que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com vistas no caráter pedagógico da condenação - Percentual dos honorários majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no Art. 85, § 11, do Novo CPC - Improvimento do apelo salvo quanto aos honorários advocatícios, os quais devem ser majorados para o percentual de 20% sobre o valor da causa, com fulcro no Art. 85, § 11, do Novo CPC. À Unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0026312-83.2017.8.17.2001, figurando como Apelante SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A e como Apelada ERIVANDA DE SOUZA CONDE; ACORDAM os Desembargadores desta TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, mantendo a sentença proferida em todos os seus termos, salvo quanto aos honorários advocatícios, os quais devem ser majorados para o percentual de 20% sobre o valor da causa, com fulcro no Art. 85, § 11, do Novo CPC, em conformidade com o Termo de Julgamento e voto do Relator, que revisto e rubricado, passa a integrar o julgado. Recife, DES. ITABIRA DE BRITO FILHO - Relator -
>
> (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 0026312-83.2017.8.17.2001, Relator: ITABIRA DE BRITO FILHO, Data de Julgamento: 23/03/2018, Gabinete do Des. Itabira de Brito Filho)
>
> Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Waldemir Tavares de Albuquerque Filho (1ª CDP) Rua Imperador Dom Pedro II, 511, Santo Antônio, RECIFE - PE - CEP: 50010-240 - F:() 1ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO Apelação/ Reexame Necessário Nº: 0027097-45.2017.8.17.2001 7ª Vara da Fazenda Pública da Capital Apelante: HILDA MARIA DOS SANTOS E OUTROS Apelado: INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO – IRH-PE E OUTROS Relator: Des. Waldemir Tavares de Albuquerque Filho Procurador de Justiça: Sílvio José Menezes Tavares EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SILTUXIMAB (SYLVANT). DOENÇA

DE CASTLEMAN MULTICÊNTRICO HIV E HHV8 NEGATIVOS. DEVER DO PODER PÚBLICO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. SÚMULA 18 DO TJ/PE. RAZOABILIDADE DA MULTA PECUNIÁRIA E DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA DEMANDANTE E DO DEMANDADO CORRETAMENTE EXCLUÍDOS DA CONDENAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO, PREJUDICADO O APELO DO DEMANDADO. NEGADO PROVIMENTO AO APELO DA DEMANDANTE. 1 - A demandante é beneficiária do SASSEPE - Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Pernambuco, criado pela Lei Complementar nº 30/2001 e gerido pelo IRH/PE, o qual se destina à prestação de serviços de assistência à saúde aos agentes públicos estaduais, com a realização de ações de medicina preventiva e curativa. 2 - Assiste razão ao demandado quanto a não incidência do CDC no caso em comento. Isso porque, de fato, o Superior Tribunal de Justiça adotou o enunciado da Súmula 608 segundo o qual "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão", cancelando a Súmula 469 de sua jurisprudência. Entretanto, apesar do pleito da demandante ser baseado na relação jurídica que a mesma mantém com o SASSEPE, cumpre ao INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO, o fornecimento do medicamento pleiteado, já que o tratamento indicado é fundamental para a manutenção da vida da demandante. 3 - A separação dos poderes não obsta à prestação jurisdicional, haja vista que, na condição de gestor do sistema de saúde, não pode o ente público eximir-se de sua obrigação e ainda postular suprimir do cidadão a garantia constitucional de acesso ao Judiciário, mais acentuadamente quando é o próprio Poder Executivo que ocasiona a suposta lesão a direito do jurisdicionado. 4 - Desse modo, a ingerência do Poder Judiciário reputa-se necessária, uma vez que visa assegurar o direito público subjetivo à saúde, garantido através de norma programática inscrita no art. 196, da CF/88. 5- O direito à saúde é um dos elementos que compõe o mínimo existencial protegido pelo Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, e não se poderia permitir que um cidadão deixasse de receber tratamento adequado por conta de alegações de cunho econômico ou burocrático. Por mais que se reconheça a necessidade de observação dos regramentos formais, em caso de conflito entre estes e o direito à saúde, via de regra, deve prevalecer este último. 6 - Ademais, se cabe ao poder público o fornecimento do medicamento/tratamento perseguido, mesmo nos casos em que não há contraprestação, motivo não há para que não seja reconhecido esse dever em relação àqueles que contribuem mês a mês com o plano de assistência à saúde oferecido aos servidores do Estado de Pernambuco. 7- para reiterar a obrigatoriedade do demandado em fornecer a medicação pleiteada, que esse Egrégio Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o Estado tem o dever de fornecer ao cidadão carente o medicamento para o tratamento de moléstia grave, ainda que não previsto em lista oficial, ao editar a súmula nº 18, publicada no DPJ do dia 15.05.07: "É dever do Estado-membro fornecer ao cidadão carente, sem ônus para este, medicamento essencial ao tratamento de moléstia grave, ainda que não previsto em lista oficial.". 8 – Não existe uma fórmula ou um padrão para se fixar o tempo para cumprimento e a multa cominatória. Os casos são analisados de acordo com as suas peculiaridades, com razoabilidade e proporcionalidade. Desta forma, considero que a multa de R$ 1.000,00 (hum mil reais), por dia de atraso, foi razoavelmente fixada, principalmente, quando se observa a jurisprudência consolidada desta E. Corte de Justiça. 9- Relativamente ao pedido de alargamento do prazo concedido ao demandado para cumprimento da obrigação, observo que o prazo estipulado de 72 (setenta e duas) horas é razoável, em face da gravidade da enfermidade da demandante. Ademais, o demandado não logrou êxito em comprovar a alegada insuficiência do prazo concedido pelo juízo a quo. 10 - Quanto aos honorários advocatícios, agiu acertadamente o juízo de primeiro grau ao deixar de condenar a demandante ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC, ante a sucumbência em parte mínima da pedido, ao passo que mantenho. 11 - Os honorários advocatícios sucumbenciais foram corretamente excluídos da condenação pelo juízo de primeiro grau, em conformidade com o que determina o enunciado 421 da Súmula do STJ, assim como o acórdão proferido por aquela Corte Superior no REsp 1.108.013/RJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. 12 - Negado Provimento ao reexame necessário, prejudicado o apelo do demandado. 13- Negado Provimento ao apelo da demandante. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos o presente recurso, Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Câmara de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao Reexame Necessário, prejudicado o apelo do demandado e NEGAR PROVIMENTO ao apelo da demandante. Recife, de de 2019. Waldemir Tavares de Albuquerque Filho Desembargador Relator W5(TJ-PE - Apelação / Remessa Necessária: 0027097-45.2017.8.17.2001, Relator: FERNANDO CERQUEIRA NORBERTO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/02/2024, Gabinete do Des. Fernando Cerqueira Norberto dos Santos)

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Fernando Cerqueira Norberto dos Santos Praça da República, S/N, Tribunal de Justiça (3º andar), Santo Antônio, RECIFE - PE - CEP: 50010-040 - F:(81) 31820202 1ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº 0007103-83.2017.8.17.9000 Juízo de Origem: 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Jaboatão dos Guararapes Magistrada: Dra. Valéria Maria de Lima Melo Estima AGRAVANTE: INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO - IRH-PE Procuradora: Dra. Sabrina Pinheiro dos Prazeres AGRAVADA: HILDA MARIA DOS SANTOS MP/PE: PJ – Dr. Aguinaldo Fenelon de Barros Relator: Des. Fernando Cerqueira Norberto dos Santos E M E N T A: CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE VEDAÇÃO legal à concessão de tutela antecipada que esgote no todo ou em parte o objeto da ação. REJEITADA. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO Siltuximab (Sylvant). PRESCRIÇÃO MÉDICA E PARECER DO NATS. DEVER DO ESTADO. ART. 196 DA CF/88. SUBSTITUIÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR BLOQUEIO JUDICIAL. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO RAZOÁVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A vedação legal à concessão de liminar que esgote no todo ou em parte o objeto da ação não se aplica aos casos em que a postergação da prestação jurisdicional possa frustrar a sua efetividade, como neste em que o não fornecimento do fármaco prescrito ao agravado poderia acarretar prejuízos graves à sua saúde, já que seu quadro clínico demanda cuidados especiais. Preliminar rejeitada. 2. Os documentos juntados aos autos eletrônicos, em especial o Laudo Médico e o Parecer Técnico do Nats, são aptos a comprovar a necessidade de utilização do medicamento Siltuximab (Sylvant) para tratamento de patologia DCM – Doença de Castleman Multicêntrico, HIV E HHV8 negativos, que acomete a parte agravada. 3. Conquanto o SASSEPE/IRH-PE esteja atrelado a um regime jurídico diverso dos seguros-saúde de direito privado, encontra-se, pela própria natureza do serviço prestado, obrigado à contraprestação de assistência à saúde, uma vez que os interesses econômicos do IRH não podem se sobrepor ao direito à saúde da parte autora/agravada. 4. A multa imposta à Fazenda Pública pelo descumprimento de ordem judicial deve ser substituída pelo bloqueio judicial, porque aquela não alcança a efetividade desejada, apenas agravando as finanças públicas ao criar mais um ônus a ser suportado por toda a sociedade. 5. Não há de se falar em tempo exíguo para cumprimento da ordem judicial que determinou o fornecimento da medicação a parte agravada, quando se trata de direito à saúde, em que há risco à integridade física do cidadão, o tempo é essencial para o tratamento clínico indicado. 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido, para tão somente substituir a astreinte imposta ao agravante, por bloqueio/sequestro de valores, caso não cumpra com a obrigação de fornecer em tempo hábil o tratamento requerido pelo agravado, mantendo-se a decisão de primeiro grau nos seus demais termos 7. Decisão Unânime. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento Nº 0007103-83.2017.8.17.9000, em que figuram como agravante, o INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO - IRH-PE, e, como agravada, HILDA MARIA DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores que integram a Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Pernambuco, por unanimidade, em conhecer do agravo de instrumento acima descrito, para rejeitar a preliminar de vedação à concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote no todo ou em parte o objeto da ação, e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para tão somente substituir a astreinte imposta ao agravante, por bloqueio/sequestro de valores, caso não cumpra com a obrigação de fornecer em tempo hábil o tratamento requerido pelo agravado, mantendo-se a decisão de primeiro grau nos seus demais termos, tudo na conformidade do relatório e voto proferidos neste julgamento. Recife, _____/_____/ de 2017. Des. Fernando Cerqueira Norberto dos Santos Relator 05/01 – PJE(TJ-PE - Agravo de Instrumento: 0007103-83.2017.8.17.9000, Relator: FERNANDO CERQUEIRA NORBERTO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/04/2018, Gabinete do Des. Fernando Cerqueira Norberto dos Santos)

Quanto ao pedido indenizatório, exsurge nitidamente que ele merece prosperar nos termos os artigos 186, 927 e seguintes do Código Civil.

O dano e a relação de causalidade estão presentes não só pela negativa de vigência do contrato, mas pelo sentido de perda em relação à reparação da saúde em momento delicado da parte autora, objetivo primordial do procedimento médico irregularmente vetado.

Nesse diapasão, vejo que a prática intentada pela ré infringe o princípio constitucional da solidariedade e contraria os arts 4º e 6º, I, CDC, no que atine à proteção à vida e à saúde, bem assim o art. 14, §1º, pelo defeito na prestação do serviço por não o fornecer da maneira esperada pelo consumidor de boa-fé.

Respeitante ao pedido alusivo aos danos morais, permite-se este Juízo deixar assentada breve conceituação pela qual "*danos morais são lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa de direito em seu patrimônio ideal, entendendo-se por patrimônio ideal, em contraposição a patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo que não seja suscetível de valor econômico*" (SILVA, Wilson de Melo da - O Dano Moral e sua Reparação, Rio, 1995, n° 01).

Encampando esta linha de pensamento, confira-se a **Súmula 35 do TJPE**: "*A negativa de cobertura fundada em cláusula abusiva de contrato de assistência à saúde pode dar ensejo à indenização por dano moral*".

Por certo, infligir ao paciente - profundamente debilitado pela moléstia que lhe acometia - o ônus de vir a Juízo buscar a efetivação das suas prerrogativas, em detrimento da paulatina dor e sofrimento que se acha experimentando, significa vulnerar-lhe com absurda iniquidade a aprazia e o bem-estar, carecendo da pronta compensação financeira.

Por suposto, "*embora geralmente o mero inadimplemento contratual não seja causa para ocorrência de danos morais, é reconhecido o direito à compensação dos danos morais advindos da injusta recusa de cobertura de seguro saúde, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada*" (STJ - AgRg no REsp 1.328.978/RS - Terceira Turma - Rel. Min. Nancy Andrighi - Julg. 13.11.2012 - DJe 20.11.2012)

O lesionamento, na espécie, não depende de prova de outros prejuízos ao patrimônio material, espiritual ou físico do postulante, porquanto se caracteriza *in re ipsa*.

Ademais, a jurisprudência mansa e pacífica do STJ assim vem entendendo em casos semelhantes:

Ademais, a jurisprudência mansa e pacífica do STJ assim vem entendendo em casos semelhantes:

> PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DECISÃO MANTIDA.
>
> 1. A jurisprudência do STJ pacificou entendimento no sentido de que a recusa injusta de plano de saúde à cobertura securitária enseja reparação por dano moral, ainda que se trate de procedimentos não emergenciais, uma vez que gera aflição e angústia para o segurado, o qual se encontra com sua higidez físico-psicológica comprometida, em virtude da enfermidade. Precedentes.
>
> 2. No caso, a recorrente teve negado o fornecimento de material necessário para a realização de procedimento cirúrgico, embora formulado oportunamente o requerimento perante a operadora do plano de saúde. Indenização fixada de acordo com as peculiaridades subjetivas do caso.
>
> 3. Na linha da jurisprudência do STJ, tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária incide, respectivamente, nas datas da citação e do arbitramento. Precedentes.
>
> 4. Agravo regimental desprovido.
>
> (AgRg no AgRg no REsp 1372202/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 10/02/2016)
>
> E ainda:
>
> APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. INTERNAMENTO DOMICILIAR - "HOME CARE". ALEGAÇÃO DE PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. TAXATIVIDADE AFASTADA. ABUSIVIDADE. SÚMULA 007/TJPE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O plano de saúde pode estabelecer quais doenças estão sendo cobertas, mas não que tipo de tratamento está alcançado para a respectiva cura. 2. Súmula 007/TJPE. É abusiva a exclusão contratual de assistência médico domiciliar (home care). 3. A jurisprudência pátria é farta no sentido de considerar o Rol de cobertura mínima da ANS como meramente exemplificativo, devendo a operadora de saúde cobrir procedimento não elencado quando imprescindível para o tratamento do beneficiário. 4. O STJ vem reconhecendo que "a recusa indevida à cobertura médica é causa de danos morais, pois agrava o contexto de aflição psicológica e de angústia sofrido pelo segurado", conforme relatoria da ministra Nancy Andrighi, no julgamento da REsp 907718 - ES. Manutenção da indenização relativa ao Dano Moral, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a qual fixou seu valor em R$ 10.000,00 (dez mil reais).5. Recurso não provido. Decisão unânime.
>
> (TJPE, Apelação 417918-6, Rel. Des. Stênio José de Sousa Neiva Coêlho, 1ª Câmara Cível, julgado em 12/01/2016, DJe 26/01/2016)

Em conclusão, tenho ser indevida a recusa da parte Ré em cobrir o fármaco nos termos solicitado pelo médico assistente, devendo ser condenada ao pagamento de indenização por dano moral, este arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) considerando a intensa extensão do dano suportado pela parte Autora e as condições pessoais das partes.

Firmado nesses pressupostos e por tudo que restou provado nos autos, tenho por imperativo julgar **PROCEDENTES** os pedidos que se acham contemplados na presente ação ordinária, para:

a) confirmar a liminar preteritamente concedida, condenar a demandada ao custeio do medicamento solicitado pelo médico assistente nos exatos termos do laudo médico, enquanto dele necessitar a paciente, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

b) imputar ainda a obrigação de indenizar a parte postulante, em aspecto compensatório pelos sofrimentos e danos extrapatrimoniais que valoro no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando a repercussão e reprovabilidade do fato, bem assim a condição socioeconômica das partes litigantes (art. 944, nCC), quantia a ser monetariamente corrigida pela tabela ENCOGE desde este *decisum* (Súmula 362, STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação (art. 405, nCC).

Por fim, constatada a hipótese do art. 487, I, do Estatuto de Ritos, extingo o feito por sentença com incursão meritória, imputando à parte ré o ônus da sucumbência, representado pelas custas processuais e honorários advocatícios ora fixados em 15% do valor total da condenação, forte no art. 85, §2º, CPC/2015.

Intimem-se. Cumpra-se.

Recife-PE, data digitalmente certificada.

Robinson José de Albuquerque Lima

Juiz de Direito

asms

Assinado eletronicamente por: ROBINSON JOSE DE ALBUQUERQUE LIMA
07/07/2024 21:15:59
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 174951617

24070721155883900000170772796

IMPRIMIR GERAR PDF